

약제 영양급여의 적정성 평가결과

tislelizumab 100mg

(테빔브라주100밀리그램(티슬렐리주맙), 베이진코리아(유))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1병 중 tislelizumab 100mg

☐ **효능·효과**

- 식도편평세포암 (Esophageal squamous cell carcinoma, ESCC)
이전 백금 기반 화학요법 치료를 지속할 수 없거나 투여 이후에 재발 또는 진행된 절제 불가능, 재발성, 국소진행성 또는 전이성 식도편평세포암 성인 환자에서의 단독요법

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2025년 제1차 약제급여평가위원회: 2025년 1월 9일

- 암질환심의위원회 심의일: 2024년 8월 28일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 ‘이전 백금 기반 화학요법 치료를 지속할 수 없거나 투여 이후에 재발 또는 진행된 절제 불가능, 재발성, 국소진행성 또는 전이성 식도편평세포암 성인 환자에서의 단독요법’에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 전체 생존기간 연장 등 임상적 유용성 개선이 인정되며, 제약사가 제시한 [REDACTED]을 적용한 경제성평가 결과, 비용효과비가 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “이전 백금 기반 화학요법 치료를 지속할 수 없거나 투여 이후에 재발 또는 진행된 절제불가능, 재발성, 국소진행성 또는 전이성 식도편평세포암 성인 환자에서의 단독요법”에 허가 받은 약제로, 현재 식도암에 허가받은 docetaxel 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 주요 참조 교과서에서 식도암 2차 치료제로서 언급되지 않으나, 임상진료지침¹⁾에서 절제불가능한 국소 진행성, 재발성 또는 전이성 식도편평세포암 2차 이상 치료제로 권고됨.
 - NCCN guideline(v4, 2024)에서는 절제불가능한 국소 진행성, 재발성 또는 전이성 식도편평세포암 2차 이상 단독요법으로 권고됨(preferred regimen, category 1)
- [3상, RATIONALE-302]²⁾ 1차 전신치료 이후, 진행성 또는 전이성 식도편평세포암(ESCC) 환자(n=512)를 대상으로, 신청품, 화학요법군³⁾으로 1:1 무작위배정, 활성약 대조, 다기관(11개국), 공개표지, 3상 임상시험 결과,
 - (1차 평가지표) 전체 생존기간은 신청품군 8.6개월(95%CI 7.5-10.4), 대조군 6.3개월(95%CI 5.3-7.0)로 유의한 차이를 보임(HR 0.7, 95%CI 0.57-0.85; p=0.0001)
 - (2차 평가지표) 무진행 생존기간은 신청품군 1.6개월(95%CI 1.4-2.7), 대조군 2.1개월(95%CI 1.5-2.7)로 유의한 차이가 없었으며(HR 0.83, 95%CI 0.67-1.01), 객관적 반응률은 신청품군 20.3%, 대조군 9.8%로 유의한 차이를 나타냄(Odds ratio 2.39, 95%CI 1.42-4.01)
 - (안전성) grade 3 이상 치료 연관 이상반응(treatment-related AE, TRAE)은 신청품군에서 18.8%, 대조군에서 55.8% 발생함. 신청품군에서 가장 흔한 TRAE는 AST

상승(11.4%), 빈혈(11.0%), 갑상선 저하증(10.2%)이었으며, 대조군에서는 백혈구 감소(40.8%), 호중구 감소(39.2%), 빈혈(34.6%)이었음.

- 관련 학회에 따르면⁴⁾, 국내에서 식도편평세포암 2차 치료에 가장 많이 사용되는 docetaxel은 전체 생존기간 중간값이 6개월 미만으로 기대여명이 매우 짧고 이후 치료 옵션에 대한 근거는 부족함.
 - 신청품은 화학요법군과 비교해 전체생존기간에서 유의한 개선을 보였으며, 안전성 측면에서 화학요법 대비 부작용 위험이 낮음.
 - 또한, 현재 국내에서 식도편평세포암에 보험 급여되는 면역항암제는 없는 실정이며, 치료제의 제한이 큰 상황으로 약제 도입이 필요하다는 의견임.

○ 비용 효과성

- 신청품의 급여기준(안), 임상연구문헌, 제외국 평가 및 학회의견 등을 고려하여 docetaxel, paclitaxel을 대체약제로 선정함.
- 신청품의 1주기(3주) 소요비용(■■■■■원)은 대체약제 1주기(3주~4주) 소요비용(■■■■■원~■■■■■원) 대비 고가임.
- (경제성평가) ‘이전 백금 기반 화학요법 치료를 지속할 수 없거나 투여 이후에 재발 또는 진행된 절제 불가능, 재발성, 국소진행성 또는 전이성 식도편평세포암환자’에 대한 “신청품(tislelizumab)”의 “비교약제(docetaxel)” 대비 비용-효용 분석 검토 결과, 기본분석 ICER는 (표시가 기준) ■■■■■원/QALY이며 (실제가 기준) ■■■■■원/QALY임.
- (위험 부담) 신청품은 치료적 위치가 동등한 치료법이 없고, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 항암제로서 「신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준 1.8.1.」 제1항 제1호 조건을 충족하여 위험분담제 적용대상에 해당하는 것으로 판단되며, ■■■■■

○ 재정 영향⁵⁾

- 제약사 제출 예상 사용량⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁷⁾은 표시가 기준 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원, 실제가 기준 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원으로 예상됨.
 - 대체약제의 대체로 추가재정소요금액⁸⁾은 표시가 기준 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원, 실제가 기준 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원 증가할 것으로 예상됨.
- ※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 제외국 약가집에 수재되어 있지 않음.

Reference

- 1) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Esophageal and Esophagogastric Junction Cancers. Version 4. 2024.
- 2) Shen L, et al. Tislelizumab Versus Chemotherapy as Second-Line Treatment for Advanced or Metastatic Esophageal Squamous Cell Carcinoma(RATIONALE-302): A Randomized Phase III Study. J Clin Oncol 2022;40(26):3065-3076.
- 3) 화학요법군: paclitaxel(n=85), docetaxel(n=53), irinotecan(n=118)
- 4) 대한항암요법연구회(), 대한소화기암연구학회() 대한종양내과학회()
- 5) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 6) 제약사 제출 예상 사용량 = 예상 환자수 × 1인당 예상 사용량 8병

	1차년도	2차년도	3차년도
예상 사용량(병)			

- 7) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가
- 8) 추가재정 소요금액은 제약사 예상 환자수, 치료기간당 소요비용 기준(대체약제는 범위의 최대-최소 중간값)으로 산출함.